Síndrome nefrítico, nefrótico e infección urinaria

SEMIOLOGIA · Clase 35 · el glomérulo que sangra, el que pierde proteínas y el germen que sube

1 · NEFRÍTICO: QUÉ ES Y QUÉ LO CAUSA

GN postestreptocócica F2 · F7
la causa más citada en niños, tras una infección estreptocócica

Otras causas
nefropatía IgA, lupus, anti-membrana basal (Goodpasture)

Todas dañan el riñón F10
lupus, diabetes, hipertensión, Goodpasture, IgA, pielonefritis, insuficiencia cardíaca (IRA prerrenal)

en niños es la causa del
puede causar el
dañan el riñón y pueden dar el

Síndrome nefrítico F1 · F2
tríada: hematuria, edema e hipertensión

2 · NEFRÍTICO: EL GLOMÉRULO INFLAMADO RETIENE AGUA Y SAL

Inflamación glomerular F6
el glomérulo se llena de células y cae la filtración

nace de la
se ve en el
al caer la filtración causa
deja pasar poca proteína: la
deja escapar hematíes: la

Retención de sal y agua F6
hipervolemia por la caída de la filtración

Hematuria «coca-cola» F3
con cilindros hemáticos

Proteinuria leve a moderada
no masiva

hallazgo dominante del nefrítico
a diferencia del nefrótico es
el agua retenida da el
puede producir
si sobrecarga el corazón
la hipervolemia eleva la
motiva los

Edema nefrítico F3
periorbitario y moderado

Hipertensión F1
con cefalea

Oliguria
puede bajar de 400 ml/24 h

Congestión
disnea, ortopnea y crepitantes por sobrecarga de volumen

si es grave lleva a las

3 · UN CASO DE NEFRÍTICO: DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES

Niña de 14 años F4
edema, PA 180/105, hematuria macroscópica, proteinuria (+): nefrítico, no nefrótico

se razona en

Cuatro niveles F6
sindrómico: nefrítico · fisiopatológico: inflamación y retención · anatómico: glomérulos · etiológico: postestreptocócica

orienta los

Exámenes útiles F5
urea, creatinina, orina, ECG, radiografía de tórax, fondo de ojo, gases

Complicaciones
edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva, IRA o IRC

puede llegar a las
guían el manejo hacia
condicionan el
de ellos sobra el

El urocultivo sobra F5
no hay datos de infección

Controlar volumen, presión y causa evita la falla renal, pulmonar o cerebral

4 · NEFRÓTICO: QUÉ LO DEFINE Y QUÉ LO CAUSA

Causas primarias
glomerulopatías primarias (cambios mínimos, GESF, membranosa); podocito: 🛍️

Causas secundarias
sistémicas, infecciones, neoplasias, fármacos

puede causar el
puede causar el

Síndrome nefrótico F8
proteinuria ≥ 3,5 g/24 h con hipoalbuminemia e hipercolesterolemia

comienza por la
se acompaña de

Hipercolesterolemia F8
dato obligatorio de examen

la dislipidemia favorece el

5 · NEFRÓTICO: LA CADENA DEL EDEMA

1 · Barrera hiperpermeable F9
falla de la barrera de filtración: podocitos borrados (🛍️)

deja pasar la
hallazgo dominante del nefrótico

2 · Proteinuria masiva F8
sale la albúmina

vacía el plasma y da la

3 · Hipoalbuminemia
la sangre pierde su albúmina

por eso cae la

4 · Presión oncótica baja
el plasma ya no retiene el agua

el líquido sale y forma

5 · Primer edema
el líquido pasa al intersticio

es menos intenso que el
baja el volumen: el riñón detecta el

6 · Volumen efectivo bajo
el riñón activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona

el SRAA provoca la

7 · Retención de sodio y agua
segundo edema que se suma al primero

suma el segundo edema al

Edema nefrótico F8
matinal en párpados, intenso, hasta la anasarca con ascitis y derrame pleural

por su origen es el

6 · CÓMO SE DISTINGUEN LOS DOS SÍNDROMES

Riesgo trombótico
trombosis venosa y embolia pulmonar por la dislipidemia

condiciona el

Nefrítico: domina la hematuria (orina «coca-cola») · nefrótico: domina la proteinuria (orina espumosa) F3 · F8

Edema nefrótico
origen oncótico; peor al despertar

no confundir con el

Edema cardiaco
origen hidrostático; de declive, peor al final del día

7 · INFECCIÓN URINARIA: EL GERMEN QUE SUBE

Mujer
uretra corta

Hiperplasia benigna de próstata F13 · F14
obstruye y deja orina residual que se infecta (varón de más de 45-50 años)

la orina residual favorece la
la uretra corta facilita la

ITU comunitaria F11
Escherichia coli en el 80-90 %

Vía ascendente F11 · F12
la flora sube por la uretra: la más frecuente

Otras vías F11
hematógena y linfática (mínima)

lleva los gérmenes a la
en la comunidad causa la
más rara vez producen la

Infección urinaria
gérmenes en la vía urinaria, desde la uretra hasta el riñón

si queda abajo produce la
si sube al riñón produce la
sin tratamiento puede dar

ITU baja
disuria, polaquiuria y tenesmo

ITU alta
fiebre de 39-40 °C y dolor lumbar

Complicaciones
absceso renal, papilitis necrotizante, septicemia, shock séptico, IRA

se explora con el
se confirma con el

Giordano positivo
orienta a pielonefritis

pueden culminar en
se confirma con el

Confirmación
leucocitos en orina y urocultivo con antibiograma

guía el tratamiento y previene

Daño renal, sepsis y muerte: lo que el diagnóstico con antibiograma evita

causa · síndrome · mecanismo · signo · síntoma · ejemplo · diagnóstico · complicación · desenlace · concepto · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología Médica 2020, U2 tema 10; Sotito 2018 U2-1; clase 10c — teoría del docente (🛍️ = literatura)